親該如何 SOS 求救，怎麼樣去尋求幫助?我們都會關心你的警語，好不好?這是我要提醒一下社會局還有衛生局的。

郭局長，我也要跟郭局長公開的提醒一下，您的學者風範、您的專業我們都非常知曉，但是可能在議會的時候，要請局長更抓準比如說我們議會同仁要問什麼?寄望局長給我們什麼答覆?大概就不太能夠像在學校裡面帶學生那樣子的一個應對，包括今天像我的記憶力也是很差的人，但是我看局長好像對科內人員也都不是那麼的熟稔，這部分要提醒一下局長，局長您請坐。衛生局局長，這個案子我有麻煩你們去查一下，有沒有?

衛生局李局長翠鳳：

有。

王議員家貞：

但是我也沒聽到你們給我一個回應，馬上就是越來越炎熱的夏天，登革熱每年的肆虐，衛生局都是最辛苦的單位，包含民政單位及衛生局單位，可是類似這樣子的衛生狀況，你們做了什麼樣子的處置?或者有沒有積極全面性的對於傳統市場，也不見得只是傳統市場，進行查核及稽查?我們看到老鼠在生肉上面這樣子的爬行，不好意思，其實你們也查得到到底是哪一家，你還敢進傳統市場去買肉嗎?局長請您回應一下。

衛生局李局長翠鳳：

好，當我們收到您的訊息後，就馬上請食藥科還有稽查科立即去進行稽查，就他們所了解這個地方是在兵仔市場的外面，所以沒有在兵仔市場的管理範圍內，那這一家因為是在晚上進肉之後……。

主席：(李議員鎮國)

好，請讓局長回復。

衛生局李局長翠鳳：

早上的時候他們的人才到，所以第一個我們馬上去稽查之後，當然我們白天去現場查的時候，因為這一家在 9 時就結束了，所以我們同仁就改成更早去到現場，那這一家自己也有承認可能在冷運冷藏時，雖然現場也有冷凍櫃，但是其實是沒有人來收這個肉品，然後直接放到冷凍櫃裡，所以第一個當然就是我們要他限期改善，他也承諾現在會請這個肉品的進貨時間進行調整，我們還會去做不定期稽查。

主席：(李議員鎮國)

謝謝家貞議員，接下來請 Ingay Tali 穎艾達利議員進行第一輪發言。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

謝謝主席。我先跟 2 位局長請教，因為衛生局長在報告裡面有提到長照 3.0 計畫的部分，那實際上我們可以看到這個計畫是根據 2.0 過來的，那 2.0 有三個非常重要的基礎，其中有提到了社區基礎、以人為本及連續照顧，對不對?然後以它的內部重點來講的話，最主要是在長照 2.0 階段性成果跟未來展望這個報告裡面所提到的，也就是我們現在講的大概在 2026 年起會進行所謂長照 3.0 的計畫，請教 2 位局長手上有沒有拿到長照 3.0 的計畫書了?

衛生局李局長翠鳳：

目前都還沒有。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

還沒有?

衛生局李局長翠鳳：

對，都還沒有公告。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

可是問題是依照剛剛的報告以及幾位同仁的詢問來講的話，你們已經開始著手要把部分業務從原來的社會局移到衛生局去了，那對於人力的配置、經費的歸屬以及要怎麼樣分權分責這些事情要怎麼樣進行?那就完全不知道了。你們要怎麼分工?我跟您講，你們 2 位一個是從學校出來的，一個是從公衛實務出身的，講起來好像我們碰到這種問題都覺得雙方是會有交集的地方，應該可以處理得很好，可是就我們長期這樣看來，也不要說多長期，就我一個菜鳥議員做到今年第 7 年，只要有一個業務是多權責管轄的，到最後就會變成三不管，然後就都不管了，所以我真的是非常、非常緊張，今天長照 2.0 如果之後在 2026 年真正要進行 3.0 銜接的時候，2 個局處要怎麼樣來做這個銜接?特別是我們現在做的夠了嗎?比方說裡面有講到以社區為基礎這件事情，您想想看，次長也特別在會後揭示了 4 個重點，以 10 分鐘為照護範圍，如果是以臺北來講的話，透過捷運等等大眾交通系統是可以做得到，但是臺南幅員這麼大，你們做得到嗎?這一個部分你們要怎麼銜接?臺南的高齡化嚴不嚴重?就 2 位所知有多嚴重?衛生局還是社會局要回答?

衛生局李局長翠鳳：

今年我們 65 歲以上人口就會達到超高齡標準，超過 20%。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

超過 20%就是超高齡的標準，對不對?

衛生局李局長翠鳳：

對。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

這是我從民政局撈取的資料，我一路從 2011 年縣市合併之後的 3 月份，因為我們現在是 3 月份，我撈取了這 10 來年的資料，我們從合併後 65 歲佔全市人口比率的 11.59%，到今年的 3 月份已經來到 19.82%了。

衛生局李局長翠鳳：

對，今年會到 20%。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

所以今年顯然會到 20%，20%是什麼觀念?這是我用民政局的系統跟主計處還有研考會這邊做人口推估的系統，從 2025 年開始每隔 10 年我們生成一個表，最後的 2070 年是這個系統的上限，可以看到紅色框框的範圍就是 65 歲以上的人口，您看這個東西代表了什麼?不管是人口的超高齡化之外，還代表社會局可能會負擔的扶養比這件事情，根據這個人口推估的資料到了 2070 年臺南市推估的人口裡面，65 歲以上的人口可能就會佔到 47.80%，青壯年只剩下 46.09%，這代表什麼?代表在扶養上也會變得非常大的壓力，所以對於民間以及我們公部門來講，我們現在就得要做非常、非常多的事情，但是問題是我們做了嗎?之前也跟大家講過，如果按照臺南市的分區來看，臺南市有 37 個區，左手邊這個圖是按老人人口的數量來做比據，當然人口數越多的地方，老人的數量就會比較高，所以我們可以看到永康、東區等等這些地方，但是另外相對的，如果我們單純從老人在當區的成數來看的話，龍崎、左鎮、大內、後壁以及楠西，不要說這些區高於

臺南的平均率，他們是都超過 4 分之 1 以上，是佔了 30 幾百分比，那這件事情在社會局要將這個部分的業務跟衛生局合併，或者是說要轉到衛生局來講，你們留下了什麼基礎給衛生局?衛生局對於這個基礎有沒有了解過?準備要怎麼做?

衛生局李局長翠鳳：

跟議座報告，我這邊的話，因為其實老化這件事情，將來一定會有很多業務比如說健康的老人可能還是會在社會局，我們的分工期限基本上就是依據衛福部，如果是在長照司的業務……。

主席：(李議員鎮國)

我們休息 10 分鐘。

主席：(李議員鎮國)

繼續開會，接下來由蔡筱薇議員、李宗霖議員、蔡蘇秋金議員 3 位聯合質詢，時間為 15 分鐘，請開始。

蔡議員蘇秋金：

謝謝主席，不好意思，謝謝筱薇議員、宗霖議員，先由我開始質詢。衛生局長，請教一下人的一生中什麼是最重要的?財富還是地位?

衛生局李局長翠鳳：

健康。

蔡議員蘇秋金：

您還算不錯，認為是健康，您身為臺南市的衛生局長，未來您有什麼政策要來照顧臺南市民的健康?請您具體說明。

衛生局李局長翠鳳：

好，我想健康的部分其實可以從幾個方面來看，第一個當然就是透過及早的篩檢，讓每位民眾早一點發現自己的健康問題，所以像在我們的慢性病裡面主要就是像癌症的篩檢就很重要，對不對？像 B、C 肝。那傳染病的部分，COVID-19 或是流感，有一些傳染病發生的時候，我們要及時的偵測，但對於我們民眾而言，最重要的而且是他最能夠做到的一個部分就是平常一定要接受施打疫苗，另外一個就是一定要做定期的健康篩檢，我想及早發現問題才是一切健康的最根本。

所以我想這 2 個部分當然是很重要，但是另外我想心理衛生的部分也是一個我們不能忽略的，所以目前我們在自殺防治的部分，不管他的工具是透過跳水，還是透過農藥等等，這些其實我們跟社會局都有社會安全網持續的就民眾心理衛生的部分提供服務，那我們的心理衛生當然也是不能等到他生病了才來做，所以我們早期的防治……。

蔡議員蘇秋金：

所以您的政策就這麼簡單嗎? 你應該要提出更好的政策來，比如我們的政策有一般的機制，我們要讓國民知道平常就應該要注意自己的健康，對不對?若是等到已經發生的時候就都已經來不及了，對不對？

衛生局李局長翠鳳：

對。

蔡議員蘇秋金：

您說大家因為生病而厭世，導致跳水等等，您說的這些都是沒有營養的，應該要有即刻的機制，你們有什麼政策可以讓我們基層的人民知道健康的重要性，不要等到生病、

出現問題的時候，才知道健康的重要性，到時就都已經來不及了，對不對？

衛生局李局長翠鳳：

對，所以我們有很多的篩檢。

蔡議員蘇秋金：

局長，您是護理師，我們知道現在大家的生活壓力很重，那因為生活壓力重，所以相對的心律不整就變成是我們市民及國人的通病，那心律不整也會引起很多的併發症，包括心血管、高血壓、低血壓，我們要怎麼去宣導及預防?以及該如何保養與治療?請您說明一下，我今天問了所有身邊的人，心律不整真的是通病，太多人都患有心律不整，那心律不整若是發作的話該怎麼辦?自己如果有心律不整的話應該要知道該如何預防，當發現身體有問題的時候，就趕緊處理，不然會引起動脈血管的一些疾病，你們要怎麼處理?請您說明讓我們的國人及市民了解。

衛生局李局長翠鳳：

我想有關於心律不整的監測，自己每天要量心率這是一定要做到的，再來像心律不整的發生，其實我們剛剛也講了，現在的諮詢專線很多，如果他覺得不舒服，其實現在有很多的服務專線，可以第一個馬上打電話到我們的這個心理衛生的服務專線，如果他感覺是壓力造成的話，我們希望能夠提早的紓解他的壓力，他如果覺得他的心律不整是跟健康有關的話，現在就醫其實在我們這裡來說都很方便，不管是衛生所或是急診室。

蔡議員蘇秋金：

就醫的話就已經中風了，來得及嗎?

衛生局李局長翠鳳：

對，其他的當然就是平常的生活型態、飲食的健康，還有我們剛剛提到的不管是在工作的壓力或者飲食，這一些一定是要及早。

蔡議員蘇秋金：

局長，因為時間的關係，我就簡單跟您說，事實上對於我們市民的健康，我們應該要有市政上的實績，既然健康是這麼的重要，其實說真的人如果身體出問題的時候，才會驚覺健康這麼的重要，為什麼我們的社會資源及醫療資源這麼嚴重?因為平常如果就做好健康的話，您看我們會需要這麼多的醫療嗎？當你到醫院的時候就會覺得我們的醫護人員是多麼的偉大，他們在照顧病人時，連我們自己的親人也不會照顧得這樣，你看他們是多麼的辛苦。

所以我希望我們要做正確的宣導，現在大家都知道，我相信您也會說，在社區也有人在宣導，運動、健康以及水的重要，結果平時你有在喝水及運動嗎？並沒有，對不對?可是我覺得你們有模擬兩可的一個問題，你們說水很重要，結果你們是如何宣導的？你們說有一些人的體質不適合喝水，如果你的體質不適合喝水，沒有在運動或排尿，就會引起水腫或是一些排尿的症狀出來，對不對?你們的宣導就是會這樣模擬兩可，要人家多喝水，結果又說一些人的體質是不能喝太多水，你們有做正確的健康宣導嗎？

衛生局李局長翠鳳：

其實以喝水這件事情來講，的確如果你是一個有腎臟病的病人，或者是本身代謝有問題的話，就不能過度飲水，所以很多時候對於自己的健康狀況要有初步的認知，那你知道你的身體如果都沒問題的話，當然運動後就要多喝水，那這個跟年齡也很有關係，所以可能要看他個別的情況。

蔡議員蘇秋金：

所以我希望您今天身為我們的衛生局長，您要將你的專業及您所知道的專業知識帶入我們的基層，好嗎？

衛生局李局長翠鳳：

好。

蔡議員蘇秋金：

因為說真的健康都不用再說了，您說的很多工作都是為了健康，結果我們政府做長照，各縣市都很羨慕我們的行動醫院，可是我們光有長照 2.0 幹嘛? 長照 2.0 就代表你已經需要人照顧了，這很重要，也很好。大家都知道養兒防老這句話，可是他還有家庭及妻兒要照顧，所以我們的長照 2.0 很好，甚至之後已經延伸到長照 3.0 了，所以我們也希望平常盡量多宣導健康的重要，長照 2.0 跟社會局長照 3.0 以後就會很辛苦了，有些家庭會負擔不起這個費用，事實上來說長照 2.0，人家有需求的時候，我們政府真的肯定一級棒，人家很需要的時候剛好有的時候就是最好的，可是再延伸到長照 3.0，你們為什麼不平常就把你們的專業知識跟身邊的人宣導，比如說心律不整要如何保養以及飲食有哪些要注意等等，我們平常對於周邊的人就要多教導及宣導，我說的有道理嗎?

衛生局李局長翠鳳：

有道理，我們鼓勵民眾加入我們的共照雲平台，我們臺南有個共照雲平台，有任何健康問題只要在上面講，我們馬上就會給予回答，所以我們希望市民通通來加入我們這個共造雲平台，我們來努力。

蔡議員蘇秋金：

局長，您當衛生局長要好好做。剩下的時間就給其他 2 位同仁，謝謝。有您擔任局長，我們的健康看得到，謝謝。

蔡議員筱薇：

謝謝秋金議員以及宗霖議員，剛剛秋金姊關於長照的問題也是有感而發。那接下來我要想跟局長確認一下，因為我們知道現在網路販售的這個商業行為有越來越多年輕人加入，也就是說有些青創業者他很容易比如有些是從國外帶貨進來的，有些是自己研發的產品，然後擺放在網路平台上面讓人購買，那我現在是希望可以加強不管是電台也好、不管是你們自己衛生局外面的電視牆也好，你們是不是應該再多，比如像交通局的立體停車場外面也有放電視螢幕，那像這樣子的一個網路販售的規定或者是限制，是不是也應該利用這樣的一個傳播系統來做放送，有這樣做嗎?

衛生局李局長翠鳳：

目前通路部分我們前一陣才剛發了一個新聞稿，也有掛在我們衛生局自己的 FB，還有我們樓下這個電視牆，那還有很多其他可以宣導的管道。

蔡議員筱薇：

局長，那您就要加強你們 FB 的瀏覽數。

衛生局李局長翠鳳：

好。

蔡議員筱薇：

但是我要提醒的是，因為有一些不當的廣告字眼其實當事者並不知道，所以當他一旦被你們抓到就直接開罰，而那個開罰的金額又很高，對於一些年輕創業者來講，那是

很大的負擔，他會覺得我初次創業，結果誤觸了這樣子的一個底線的時候，賠了那麼多錢，甚至可能已經沒有辦法再繼續營業等等，我希望不要有這樣子的情況。

因為現在目前還是一樣登革熱流行期又要來了，登革熱對我們大家來講都是要非常小心防範的，我希望可以加強大樓裡面的，包含他們的污水槽還是地下，因為我們知道有一些舊大樓的地下室甚至是已經是淹水的狀況，我上次有跟你們提到我們成大里，那有去做投藥的動作以外，其他大樓的部分是不是應該也要加強宣導?之前有大樓就因為這樣子被你們開罰，整棟大樓都想說這個地方也不是在我們家，是屬於公共區域，那要被開罰，他們覺得是不是可以加強做宣導?我們用意還是希望是宣導，而不是為了要開罰，好不好?

衛生局李局長翠鳳：

我想大樓地下室部分我們已經做了一個專案計畫，現在正在執行，就是我們會清查所有的大樓是不是有積水的情況，這個專案計畫已經在執行了。

蔡議員筱薇：

好，我將剩下的時間給宗霖議員。

李議員宗霖：

感謝筱薇議員。衛生局李局長不好意思，順便請問一下，您知道 RSV 嗎?

衛生局李局長翠鳳：

上呼吸道融合病毒。

李議員宗霖：

對，因為我們最近發現在 2023 年的時候 RSV 在嬰幼兒發生的狀況是 2022 年的 1.7 倍，而且更是 2021 年 4 倍，那後來我們研究之後發現其實這個東西對於新生兒有非常強的保護力，那在臺灣新生兒疾病的致死率中，其實 RSV 是佔第三名，第一名是遺傳性的疾病，第二名可能是疾病或是重症，那第三名就是這件事情，所以對於這個部分如果我們有機會可以來防範的話，這個疫苗是不是蠻值得我們去注射的，我相信您也是一位母親，如果對我們新生兒有這樣的照顧的話，您覺得妥不妥當?

衛生局李局長翠鳳：

其實我自己個人認為 RSV 疫苗的一個發展其實對我們真的是一個很大的助力，這是第一個我必須要提的，因為這個 RSV 現在新的疫苗已經有得到國際上很多的認證，那在中央也就是臺灣的 CDC 也有一個疫苗的委員會，其實我最近看到他們開會在審這個 RSV 疫苗的時候，他們也覺得是很值得推薦的，只是說目前他們評估的結果還是自費的，委員會的結論是覺得成效不錯，但是他們認為目前還是鼓勵用自費。

李議員宗霖：

那自費的話，在費用上面對於市府來講可能就會比較有一點問題，是不是?

衛生局李局長翠鳳：

目前的話這個疫苗可能在 6 月的時候會進到臺灣，將來的話我們也會覺得其實它對孩子如果有非常好的保護作用，可以在媽媽懷孕的末期大約 27、28 週時來接種，那孩子出生時就可以避免，所以這其實是一個非常、非常好的政策，我們也一直希望中央可以推行。

李議員宗霖：

局長，我這邊是希望 2 件事情，這不一定要中央做，第一件事情就是希望你們可以

幫忙去宣導有這樣子的疫苗讓家長知道，因為我相信在少子化的現在，每一個家長對於自己的新生兒跟未來的寶貝一定希望給他最好的待遇，所以當他在有能力的時候，讓他知道 RSV 其實是有疫苗可以來防範的時候，我相信他們都會願意注射。

第二個就是去年，也很感謝你們，在帶狀皰疹疫苗上面也感謝黃偉哲市長，他其實給了我們這個中低收入戶跟一些弱勢族群優先的疫苗注射，所以讓這些比較弱勢的族群有保護力，那我希望未來在這一塊，因為我相信 RSV 這個東西其實到後期新生兒很容易變成是有氣喘跟後續的後遺症，那如果讓他有保護力之後，這些比較弱勢的族群他們的小朋友其實在往後的生長，我相信也會比較順利，這個部分我們再一起來推行，好不好?

衛生局李局長翠鳳：

好。

李議員宗霖：

這部分再拜託一下。

衛生局李局長翠鳳：

我想宣導的部分我們一定會努力，我們會讓每一個婦產科至少懷孕的媽媽都知道這件事。

李議員宗霖：

好，謝謝局長。

衛生局李局長翠鳳：

謝謝。

李議員宗霖：

接下來我們問一下社會局局長，您知道臺灣唯一 24 小時的托育據點在哪裡嗎?臺灣唯一一個 24 小時的托育據點在高雄，其實全世界第一個優先的案例，我們日本的朋友已經先離開了，其實第一個優先的案例是在日本的風俗區，但是我覺得在臺南其實也蠻適用這樣一個 24 小時的托育據點，我們現在不管是超商或是南科，因為我們的「十萬青年十萬崗、輪班救臺灣」，所以其實蠻多年輕的爸媽是要輪班上班的，那如果有這樣的一個 24 小時托育據點，可以讓他們在需要輪班或是臨時有狀況的時候，暫時把小朋友安放在一個政府認可的單位，也不用擔心保母或者是其他的托嬰單位有虐兒的狀況，直接由政府來提供這樣子的協助，您覺得好不好?

社會局郭局長乃文：

目前我們對於居家的保母有很明確的考核跟訓練，當然如果是長期的問題不是臨托的話，我個人會覺得還是正式建立一個照顧者關係會比較好。

李議員宗霖：

您覺得建立照顧者的關係比較好，所以高雄這個托育據點不好?

社會局郭局長乃文：

如果偶爾臨托必須解決問題，因為……。

主席：(李議員鎮國)

接下來請陳怡珍議員進行第一輪發言。

陳議員怡珍：

謝謝主席。我想請教衛生局局長，其實我們全國兒童早期療育的人數，我之前看到的數據是大約 4.8 萬人，那臺南大約是多少人?

衛生局李局長翠鳳：

芷玲妳知道我們現在大約多少人嗎?做早療的人數是在社會局，我們是篩檢，人數是社會局在管。

陳議員怡珍：

早療人數，那你們篩檢不用管人數就對了?

衛生局李局長翠鳳：

我們篩完要轉介到社會局做早療的治療。

陳議員怡珍：

那早療人數大概有多少人?社會局這邊誰可以回答?臺南的部分。

社會局郭局長乃文：

我們這邊是 5,966 人。

陳議員怡珍：

我們臺南的部分是 5,966 人，好，局長請坐，科長請坐。其實我去年在總質詢的時候就有討論到，全臺 0 到 6 歲都是我們早療補助的一個範圍，那 6 歲以上的部分當時六都裡面臺北、新北、桃園、臺中都已經把療育訓練納入弱勢兒童的醫療補助，新北市補助發展遲緩兒療育的訓練到 12 歲；臺北、桃園、臺中補助提升到 18 歲，那補助資格是有身障、重大傷病卡的對象；當時高雄表示會修改補助辦法，預計在今年 6 月前上路，那臺南看起來是侷限於 6 歲以下的小朋友，讓很多家長會覺得其實孩子還是很需要這個資源的延長，所以我們看到高雄最近已經公告了，高雄已經公告早療補助延長到 18 歲，就是到未滿 18 歲的部分，那臺南呢?我們臺南的部分呢?

社會局郭局長乃文：

是，議座，去年 10 月的時候我們其實已經開始做這件事情的研議，那在今年的 1 月跟 3 月我們實際上都已經在做府內之間各個不同局處的溝通，目前公文都還在努力當中，我們也很渴望可以看看能不能在預算通過的情況之下，可以往 18 歲這個部分來服務。

陳議員怡珍：

好，我想就是一個期程，因為家長其實都很關注這個議題，因為就像您說的臺南也有 5 千多個孩子，5 千多個家庭其實有這樣的需求，那這個療育的費用其實很長而且很需要這樣經費的支持，能夠減輕他的一些負擔，其實他們本身還是要負擔蠻多的費用，但是說減輕可以讓他們感受到政府的善意，所以我想這個部分社會局有沒有預計什麼時間點可以來完成，像高雄已經通過了，那臺南呢?大概什麼時間點可以來完成?

社會局郭局長乃文：

我們非常的努力，事實上我們已經幾乎是到最後一關，但是因為現在有預算的問題，那我們非常的渴望看能不能 8 月就能夠有一些正式的回應。

陳議員怡珍：

好，我覺得到 8 月還是有一段時間，我想在這個會期裡面，我期待在這個定期大會能有一個具體的回應，也希望能夠正式上路，因為我想高雄都做得到了，而且其實這個就是一個政策的決定，我想這個部分有 5 千多個家庭，對孩子來講真的是很重要的照顧，而且越早的早期照顧，越能減輕後續照護的壓力，這個部分也請社會局再跟市長密切的爭取一下，也希望能夠加速通過，也希望在這個定期大會期間就可以來完成，這個部分

再麻煩局長，謝謝。

衛生局局長，我們之前討論到帶狀皰疹疫苗，我們之前在質詢時有爭取，也很謝謝市長的支持，衛生局也很努力已經在今年正式上路，我看到你們的報告中目前已經有71位民眾受益，也包含3位原住民，那250萬算起來應該大概可以打108位。

衛生局李局長翠鳳：

對，108位，大約1百多位。

陳議員怡珍：

那扣掉71位，現在又才剛上路，局長，政策已經上路多久?

衛生局李局長翠鳳：

就是從1月份到現在。

陳議員怡珍：

1個月?

衛生局李局長翠鳳：

4個月。

陳議員怡珍：

4個月?

衛生局李局長翠鳳：

對。

陳議員怡珍：

好，但是你們是從3月6日起，你們這個政策發布是什麼時候?

衛生局李局長翠鳳：

我們其實是從1月1日，不過因為我們又再買疫苗進來等等，請問琬淇科長我們是從幾號開始施打?

衛生局疾病管制科黃科長琬淇：

報告議座，我們今年就是從那時候發佈記者會，也就是114年3月6日開始施打。

陳議員怡珍：

那開始施打到現在才一個月而已，才1個月而已就已經用掉71個，只剩下37個人可以施打，所以其實這個需求是非常、非常的高，那現在用完了怎麼辦?我看起來大概不用再一個月就會用完了，那後續有需要施打的這些市民朋友怎麼辦?

衛生局李局長翠鳳：

因為我想這是逐年編列，因為終身你只要施打過……。

陳議員怡珍：

我知道今年的預算你們沒有辦法再追加了，所以你們明年要怎麼去規劃明年的預算?而且怎麼去做族群的擴大?看起來民眾對這個需求是很殷切的，所以才上路一個月就已經用掉一半以上了，已經快用完了，所以大家對這個補助是非常期待的，所以應該要去擴大。

主席：(李議員鎮國)

請蔡宗豪議員進行第一輪發言。

蔡議員宗豪：

謝謝主席。2位局長我想跟你們說其實現在的社會壓力還有一些工作壓力，我想很

多人都有一種越來越多人扛不住的狀況，在 2024 年的全國輕生的人數有幾位?這是我等一下想問的，因為我們有看到 2023 年衛福部的資料顯示有 3,898 人。

衛生局李局長翠鳳：

對。

蔡議員宗豪：

我想要知道在去年度還有前年度，我們臺南市的輕生人數有幾位?

衛生局李局長翠鳳：

我們臺南市在 112 年的時候有 318 位。

蔡議員宗豪：

您是說 112 年，也就是 2023 年?

衛生局李局長翠鳳：

對，那 113 年的時候是 286 人。

蔡議員宗豪：

所以人數是減少的?

衛生局李局長翠鳳：

對，我們的人數是在減少。

蔡議員宗豪：

好。

衛生局李局長翠鳳：

另外按照每 10 萬人口的死亡率計算標準化，其實全國大概是 12.7%，那我們臺南市也低於全國的平均大概是在 12%左右，那今年人數又降低的話，死亡率應該還是在下降當中。

蔡議員宗豪：

衛生局長您請坐，簡單來說以全國的比例來講我們可能佔了快一成?

衛生局李局長翠鳳：

對，以 3 千多人來講，因為我們現在是 286 人，還不到一成。

蔡議員宗豪：

雖然我們人數有減少了，但是我們也希望可以化整為零是最好的，那希望我們市政府在做心理諮商以及自殺防治的這一區塊，可以真的有效回應一些高風險族群他們的需要，是否可以在問題發生的之前，就可以先讓他們被接住、被看見?這是我今天想要問的一個核心問題。

衛生局李局長翠鳳：

這個問題我們當然也非常重視，所以像去年我們一直在宣導我們有 44 個心理衛生據點，我們都可以接受這個服務，這一年的話目前的服務量可能光是來現場諮商部分就大概有 3,700 多人。

蔡議員宗豪：

好，既然有這麼多人來諮商，那我想問的第二個問題是我們心理師的配置是否足夠?

衛生局李局長翠鳳：

目前來講的話我們都是用中央的補助，是按照人口數來補助我們的心理師，當然民眾進來都是希望能立刻就可以接受服務，那如果說時間沒辦法的話，我們也會有排程，